

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 1 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

1. **Concerne** : Médecins et sages-femmes du Pôle Mère Femme

2. **Application** :

Définition de la rupture des membranes

Le diagnostic de rupture des membranes est d'abord clinique et il peut nécessiter un test biologique en cas de doute clinique. *La seule positivité du test biologique IGFBP-1 ou PAMG-1 ne doit pas être retenue comme un argument formel de Rupture des membranes en raison d'un risque de faux-positif notamment en présence de modifications du col utérin.*

Conduite à tenir :

- Examen général
- Examen au spéculum confirmant la présence de liquide amniotique, test à la toux positif (*cette situation ne nécessite pas de confirmation par un test biologique de détection de liquide amniotique*)
- Toucher vaginal
- Examen cardiotocographique afin d'évaluer le bien-être fœtal, la présence de contractions utérines et des signes d'infection intra-utérine
- Si doute clinique sur la Rupture des membranes : échographie pour évaluer la quantité de liquide amniotique

Indication test de détection de liquide amniotique

Si la rupture n'est pas franche, rechercher :

- Trace de liquide au spéculum
- Oligoamnios à l'échographie
- Tests détection de liquide amniotique positif

Rupture des membranes possible si 2/3 éléments positifs

Un test de détection de liquide POSITIF isolément positif n'est pas suffisant pour affirmer une rupture des membranes

Intitulé et référence du document associé : aucun			
REDACTION : 19/08/2026 Dr ECHALARD Julien Médecin Junior - Obstétrique Signé	VERIFICATION : 17/09/2026 Mohcine AICH Qualiticien – Direction Qualité Signé	VALIDATION : 17/09/2026 Dr ECKMAN LACROIX Astrid PH Gynéco-obstétrique Signé	APPROBATION : 17/09/2026 Pr MOTTET Nicolas Chef du pôle mère femme Signé
Liste de diffusion : Médecins et Sages-Femmes du Pôle Mère Femme via le logiciel institutionnel de GED et les classeurs virtuels unité PMF et salles de naissance			

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 2 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

A. RUPTURE DES MEMBRANES et INFECTION INTRA UTERINE

a. Définition

La présence d'une fièvre maternelle d'emblée $\geq 39^{\circ}$ C en une seule prise

Ou l'association :

D'une fièvre maternelle ($\geq 38^{\circ}$ C), confirmée à 30 minutes d'intervalle et d'au moins 1 signe suivant :

- Contractions utérines douloureuses en dehors du travail
- Tachycardie maternelle > 100 bpm
- Tachycardie fœtale (> 160 bpm),
- Liquide amniotique purulent
- Leucocytose $\geq 15\,000/\text{mm}^3$

Ou l'association

D'au moins 2 signes suivant :

- Tachycardie fœtale (> 160 /mn),
- Liquide amniotique purulent
- Leucocytose $\geq 15\,000/\text{mm}^3$

Reflexes

- *L'absence de fièvre maternelle n'est pas suffisante pour écarter la suspicion d'une infection intra-utérine débutante*
- *L'amélioration de la température sous paracétamol ne doit faire écarter la suspicion d'infection intra utérine*
- ***Pas d'administration de paracétamol ou d'antibiotiques sur une seule prise de température***
- *Avant toute administration de paracétamol, vérifier la température maternelle*

Bilan biologique en cas de suspicion d'infection intra-utérine

- NG – CRP
- Bilan de coagulation, ionogramme sanguin
- PV et ECBU
- Hémocultures avec recherche de germes aérobies et anaérobie

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 3 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

b. Prise en charge en salle de naissance :

- Poursuite de la prise en charge et envisager la naissance selon la tolérance maternelle et fœtale.
- Rechercher des signes de gravité maternels :

Signes de gravité maternels en cas d'IIU

- Une hypotension artérielle
- Tachycardie maternelle
- Oligurie < 0,5 ml/kg/h
- Tachypnée avec FR > 22 et ou saturation en air ambiant < 95%



Calcul du Quick SOFA score

- FR ≥ 22 (1 pts)
- TAS < 100 mmHg (1 pts)
- Trouble de la conscience (confusion, désorientation, Glasgow < 15) (1 pts)

Un score ≥ 2 nécessite une prise en charge conjointe avec le médecin anesthésiste réanimateur

Recherche de signes toxiques : sepsis réfractaire, érythrodermie, diarrhée, leucopénie <4G/L

Bilan à la recherche de signes de défaillance multiviscérale

- Lactatémie
- Créatinémie
- ASAT/ALAT, bilirubinémie totale
- Thrombopénie
- Bilan de coagulation

Il n'y a pas de preuve que la césarienne soit associée à une amélioration du pronostic néonatal, quel que soit l'âge gestationnel. L'infection intra-utérine ne justifie donc pas à elle seule le recours à une césarienne.

→ La césarienne en cas d'infection intra-utérine est réservée aux indications obstétricales habituelles.

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 4 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

c. Adaptation de l'antibiothérapie en cas de diagnostic d'infection intra-utérine :

En l'absence d'allergie sévère aux β lactamines	En cas d'hypersensibilité sévère aux β lactamines
Céfotaxime IV 1g x 3/j <i>Administration en 30 à 60 min</i> + Amikacine : 25 mg/kg/j en IVL <i>Une administration par 24 h sur 30 minutes</i> <i>Ne pas poursuivre l'Amikacine au-delà de 48h</i>	Vancomycine 15 mg/kg x 2/j en IVL <i>Administration en 60 min minimum pour 500 mg et 2h pour 1g</i> <i>2g max par administration</i> + Amikacine : 25 mg/kg/j en IVL <i>Une administration par 24 h sur 30 minutes</i> <i>Ne pas poursuivre l'Amikacine au-delà de 48h</i>
En cas de signes de gravité maternelle → Avis médecin réanimateur	
En cas de signes toxiques → ajouter Clindamycine 900 mg x 3/j IVL <i>Administration sur 60 minutes</i>	

Envoi du placenta en bactériologie et anatomopathologie en cas de signe d'infection intra-utérine

La **confirmation histologique** repose sur la **présence de neutrophiles** dans des sites anatomiques caractéristiques (amnios, chorion, plaque chorale, cordon)

- **Chorioamniotite histologique** = neutrophiles dans les **membranes / plaque chorale** → signe d'inflammation **d'origine maternelle**.
- **Funisitis** (cordon) = neutrophiles dans les **vaisseaux du cordon ou gelée de Wharton** → signe d'inflammation **foétale (FIRS)**

d. Conduite à tenir post partum :

- Poursuivre la bi-antibiothérapie jusqu'à réception des résultats bactériologiques.



Ne pas dépasser 2 jours pour les aminosides.

- Visite post natale au CHU

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 5 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

B. PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES A TERME ≥ 37 SA

Les ruptures des membranes ≥ 37 SA sont dénommées « **ruptures des membranes à terme (RMT)** » (le terme « rupture prématurée des membranes (RPM) » ne doit plus être utilisé car source de confusion).

Un délai de 12 heures après la rupture définit la « rupture des membranes à terme avant travail ».

a. Prise en charge

S'il n'existe pas de signe de travail spontané ni d'infection intra-utérine et quel que soit le statut du Streptocoque B, la patiente est hospitalisée en PMF

- PCR Streptocoque B par prélèvement vaginal si dépistage streptocoque B non fait en cours de grossesse (cf procédure spécifique)

Si le Streptocoque B est positif, un déclenchement est proposé à la patiente dans les 24 à 36h qui suivent la rupture. **Présentation du dossier au staff quotidien et/ou décision du Senior de garde qui a rencontré la patiente.**

Si le Streptocoque B est négatif, le choix est laissé à la patiente entre un déclenchement 24 heures minimum après la rupture ou une conduite à tenir expectative qui ne devra pas dépasser 5 jours.

→ **Surveillance monitoring 2 fois par jour pendant la durée de l'hospitalisation**

→ **Surveillance maternelle à la recherche de signe d'infection intra utérine**

b. Antibiothérapie durant l'hospitalisation

- **si PCR SGB positive ou si PV SGB positif pendant la grossesse :** antibiothérapie à débiter immédiatement
- **si PCR SGB négative :** antibiothérapie à débiter à H12 de la rupture

En l'absence d'allergie aux pénicillines	En cas d'hypersensibilité non sévères aux β lactamines	En cas d'hypersensibilité sévère aux β lactamines
Amoxicilline PO 1g/8h <i>jusqu'à l'entrée en travail</i>	Céfazoline IV 30mg/kg x 3/j <i>Administration en 3 à 4 min</i> <i>2g max par prise</i>	Azithromycine PO 1g le 1 ^{er} jour en prise unique puis 500 mg par jour en prise unique OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j <i>Administration en 60 min minimum</i> <i>(attention à adapter à l'antibiogramme du germe si disponible)</i>

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 6 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

c. Antibiothérapie systématique en cours de travail

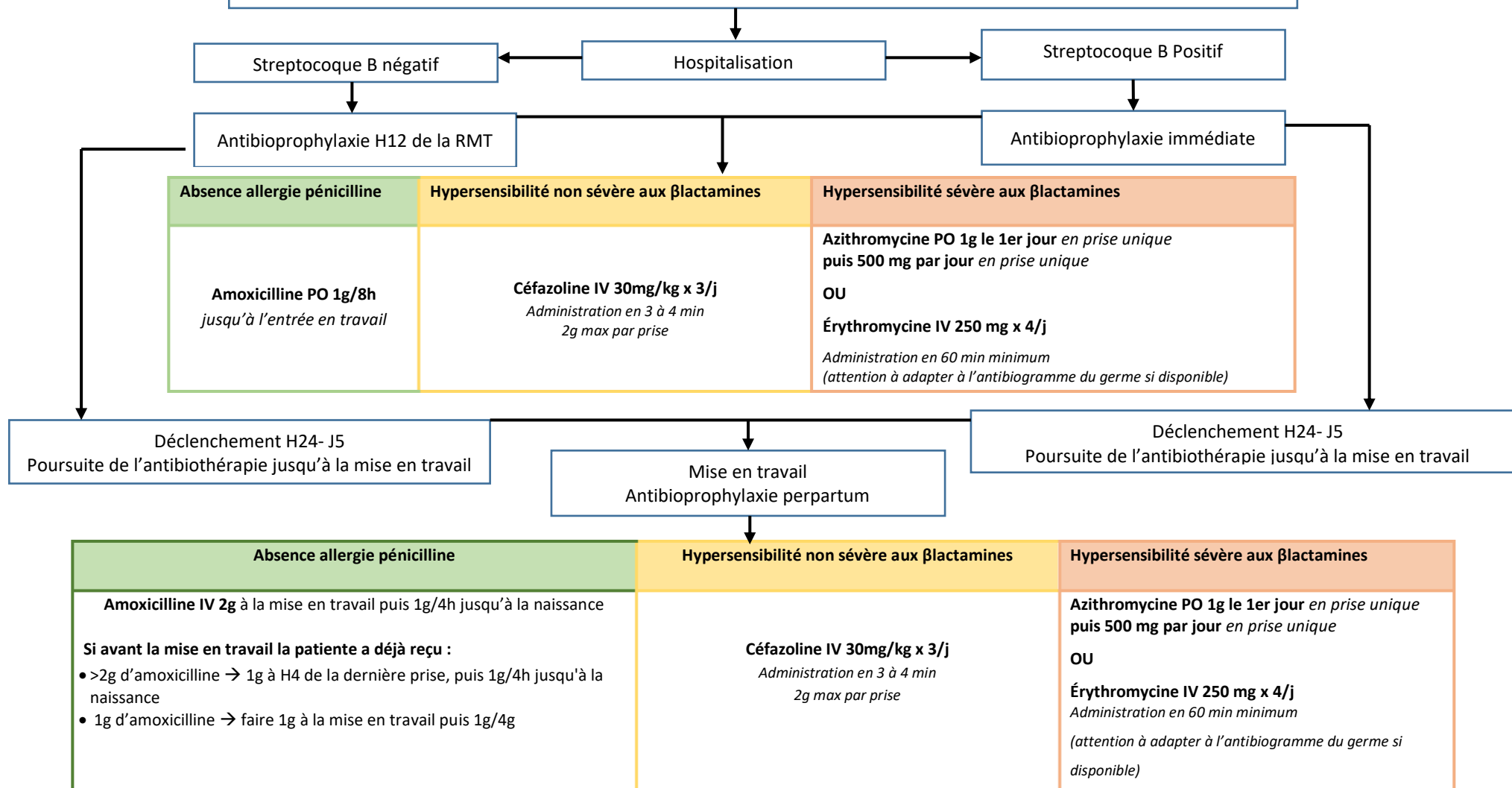
- Si PCR ou PV positif à streptocoque B
- Ou si délai entre rupture et mise en travail > 12h

En l'absence d'allergie aux pénicillines	En cas d'hypersensibilité non sévères aux βlactamines	En cas d'hypersensibilité sévère aux βlactamines
Avant la mise en travail si : • <u>la patiente a déjà reçu ≥2g d'Amoxicilline :</u> → Amoxicilline IV 1g à H4 de la dernière prise, puis 1g/4h jusqu'à la naissance • <u>la patiente a reçu seulement 1g d'Amoxicilline :</u> → Amoxicilline IV 1g à la mise en travail puis 1g/4h jusqu'à la naissance • <u>la patiente n'a pas eu d'antibiothérapie :</u> → Amoxicilline IV 2g à la mise en travail puis 1g/4h jusqu'à la naissance	Céfazoline IV 30mg/kg x 3/j <i>Administration en 3 à 4 min 2g max par prise</i>	Azithromycine PO 1g le 1^{er} jour en prise unique puis 500 mg par jour en prise unique OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j <i>Administration en 60 min minimum</i> <i>(attention à adapter à l'antibiogramme du germe si disponible)</i>

d. En cas de signes d'infection intra-utérine, adaptation de l'antibiothérapie :

 Se référer au paragraphe A-c de la page 4 du protocole « **Adaptation de l'antibiothérapie en cas de signes d'infection intra-utérine** »

Rupture des membranes $\geq$ 37SA



Si Signes d'infection intra-utérine

Céfotaxime 1g x 3/j IV + Amikacine 25 mg/kg/j (pendant 48 h maximum) en IV en une injection par 24 h sur 30 minutes

En cas d'hypersensibilité sévère aux β lactamines : **Vancomycine 15 mg/kg (2g max) x2/j + Amikacine 25 mg/kg/24h**

En cas de signe toxinique ou de choc septique réfractaire : avis médecin réanimateur et ajout **Clindamycine 900 mg x 3/j**

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 8 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

C. PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES ENTRE 23 et 37 SA

a. Prise en charge

- S'il n'existe pas de signe de travail spontané ni d'infection intra-utérine, la patiente est hospitalisée en PMF
- Corticothérapie anténatale systématique et immédiate avant 34 SA sans attendre les résultats du bilan infectieux même en l'absence de CU ou de modifications cervicales.
- Si mise en travail ou suspicion de mise en travail < 32 SA → Perfusion de sulfate de Magnésium selon protocole.
- Tocolyse de courte durée (maxi 48h00, non systématique, à *envisager surtout entre 23 et 30 SA*, en l'absence de signes cliniques d'infection intra-utérine)
- Bilan biologique :
 - PV et ECBU
 - NG, CRP
 - Bilan de coagulation (TP ; TCA ; fibrinogène)
 - Recherche d'agglutinines irrégulières (RAI)
 - 2 déterminations de groupe sanguin rhésus si non valide
 - +/- examen bactériologique du fil ou de la bandelette de cerclage du col après décerclage,
 - +/- prélèvement d'endocol chez les femmes à risque d'Infection Sexuellement Transmissible
- Pas de repos strict au lit → déambulation autorisée +++
- Bas de contention type 2 adaptées à la taille de la patiente
- Consultation pré-anesthésie
- Entretien obstétrico-pédiatrique systématique entre 23 et 26 SA.

→ **Entre 23 et 26 SA, surveillance fœtale par Bdc ou ERCF selon les conclusions de l'entretien obstétrico-pédiatrique**

→ **A partir 26 SA Surveillance monitoring deux fois par jour en attendant les résultats bactériologiques puis 1 fois par jour si bactériologie négative, à adapter selon le terme et les conclusions de l'entretien obstétrico-pédiatrique.**

→ **Surveillance maternelle à la recherche de signe d'infection intra utérine**

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 9 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

b. Antibiothérapie durant l'hospitalisation

➤ Débuter immédiatement (sans attendre les résultats du PV) :

En l'absence d'allergie sévère aux β lactamines	En cas d'hypersensibilité sévère aux β lactamines	
Céfotaxime : 1g x 3/j IVL <i>Administration en 30 à 60min</i>	Aztréonam 1g x 3/j IVL + <i>Administration en 30 à 60min</i>	Azithromycine PO 1g/j <i>en prise unique</i> OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j <i>Administration en 60 min minimum</i>
<u>Nb</u> : en cas de rupture de stock d'Aztréonam : Amikacine : 15 mg/kg/j en IVL <i>en une administration par 24 h sur 30 minutes</i>		
<i>Ne pas poursuivre l'Amikacine au-delà de 48h et garder bithérapie</i>		
Attention à adapter à l'antibiogramme du germe si disponible		

➤ Après réception de la bactériologie définitive

- Les prélèvements bactériologiques (PV, ECBU, Hémoculture) sont négatifs :
 - Arrêter le traitement antibiotique
 - Discuter un retour à domicile avec surveillance sage-femme à domicile selon le lieu d'habitation (< 30 min du CHU) et le type de présentation fœtale. *(Un relai avec la maison des familles pourra se discuter selon les conditions d'éligibilité (engagement maternité)).*
- Les prélèvements bactériologiques (PV, ECBU, Hémoculture) sont positifs :

L'antibiothérapie est adaptée à l'antibiogramme pour une durée de 7 jours au total.

- Présence d'une vaginose

Métronidazole PO 1 g/j pendant 7 jours (ou **Secnidazole PO 2 g** en dose unique)

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 10 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

c. Rythme de surveillance des bilans biologiques et prélèvements bactériologiques

➤ **Si bilan infectieux d'entrée négatif :**

- Pas de bilan infectieux de contrôle en l'absence de signe clinique
- Refaire un bilan infectieux (NG, CRP, PV et ECBU +/- hémocultures) en cas de mise en travail ou si apparition de signes cliniques pouvant faire évoquer infection urinaire ou une infection intra-utérine,
 - Tachycardie fœtale > 160 bpm
 - Contractions utérines douloureuses
 - Métrorragies
 - Hyperthermie $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - Liquide amniotique teinté
 - Signes fonctionnels urinaires

➤ **Si bilan infectieux initial positif**

- Refaire PV et ECBU après la fin du traitement antibiotique adapté

En cas de germes atypiques

- *Le streptocoque du groupe A ou pyogenes*
- *Entérobactéries du groupe 3 (Enterobacter, Citrobacter freundii, Providencia, Morganella, Hafnia)*
- *Pseudomonas aeruginosa*

→ un traitement antibiotique adapté doit rapidement être mis en place avec avis de l'équipe de maladies infectieuses

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 11 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

d. Antibiothérapie systématique en cours de travail

En l'absence d'allergie sévère aux β lactamines	En cas d'hypersensibilité sévère β lactamines	
Céfotaxime : 1g x 3/j IVL Administration en 30 à 60min	Aztréonam 1g x 3/j IVL + Administration en 30 à 60min	Azithromycine PO 1g/j en prise unique OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j Administration en 60 min minimum
<u>Nb</u> : en cas de rupture de stock d'Aztréonam : Amikacine : 15 mg/kg/j en IVL en une administration par 24 h sur 30 minutes Ne pas poursuivre l'Amikacine au-delà de 48h et garder bithérapie		
Attention à adapter à l'antibiogramme du germe si disponible		

e. En cas de signes d'infection intra-utérine, adaptation de l'antibiothérapie :

 Se référer au paragraphe A-c de la page 4 du protocole « Adaptation de l'antibiothérapie en cas de signes d'infection intra-utérine »

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 12 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

D. PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES < 23 SA

a. Prise en charge

- S'il n'existe pas de signe de travail spontané ni d'infection intra-utérine, la patiente est hospitalisée en PMF
- Pas de cure de corticoïde envisagée avant 23 SA
- Evaluation de la vitalité fœtale par écoute externe des BDC 1 fois par jour
- Bilan biologique à l'entrée:
 - PV et ECBU
 - NG, CRP
 - Bilan de coagulation (TP ; TCA ; fibrinogène)
 - Recherche d'agglutinines irrégulières (RAI)
 - 2 déterminations de groupe sanguin rhésus si non valide
 - +/- examen bactériologique du fil ou de la bandelette de cerclage du col après décerclage,
 - +/- prélèvement d'endocol chez les femmes à risque d'Infection Sexuellement Transmissible
- Echographie diagnostique et présentation du dossier en RCP du CPDPN

b. Antibiothérapie durant l'hospitalisation

- **A débiter immédiatement (sans attendre les résultats du PV) :**

En l'absence d'allergie sévère aux β lactamines	En cas d'hypersensibilité sévère aux β lactamines	
Céfotaxime : 1g x 3/j IVL <i>Administration en 30 à 60min</i>	Aztréonam 1g x 3/j IVL <i>Administration en 30 à 60min</i>	Azithromycine PO 1g/j <i>en prise unique</i> OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j <i>Administration en 60 min minimum</i>
Nb : en cas de rupture de stock d'Aztréonam : Amikacine : 15 mg/kg/j en IVL <i>en une administration par 24 h sur 30 minutes</i>		
<i>Ne pas poursuivre l'Amikacine au-delà de 48h et garder bithérapie</i>		
Attention à adapter à l'antibiogramme du germe si disponible		

➤ Si bilan infectieux d'entrée négatif :

- Envisager une sortie avec surveillance hebdomadaire par SF à domicile
- Nouvelle hospitalisation à partir de 23-24 SA selon les comptes rendu de l'entretien obstétrico-pédiatrique

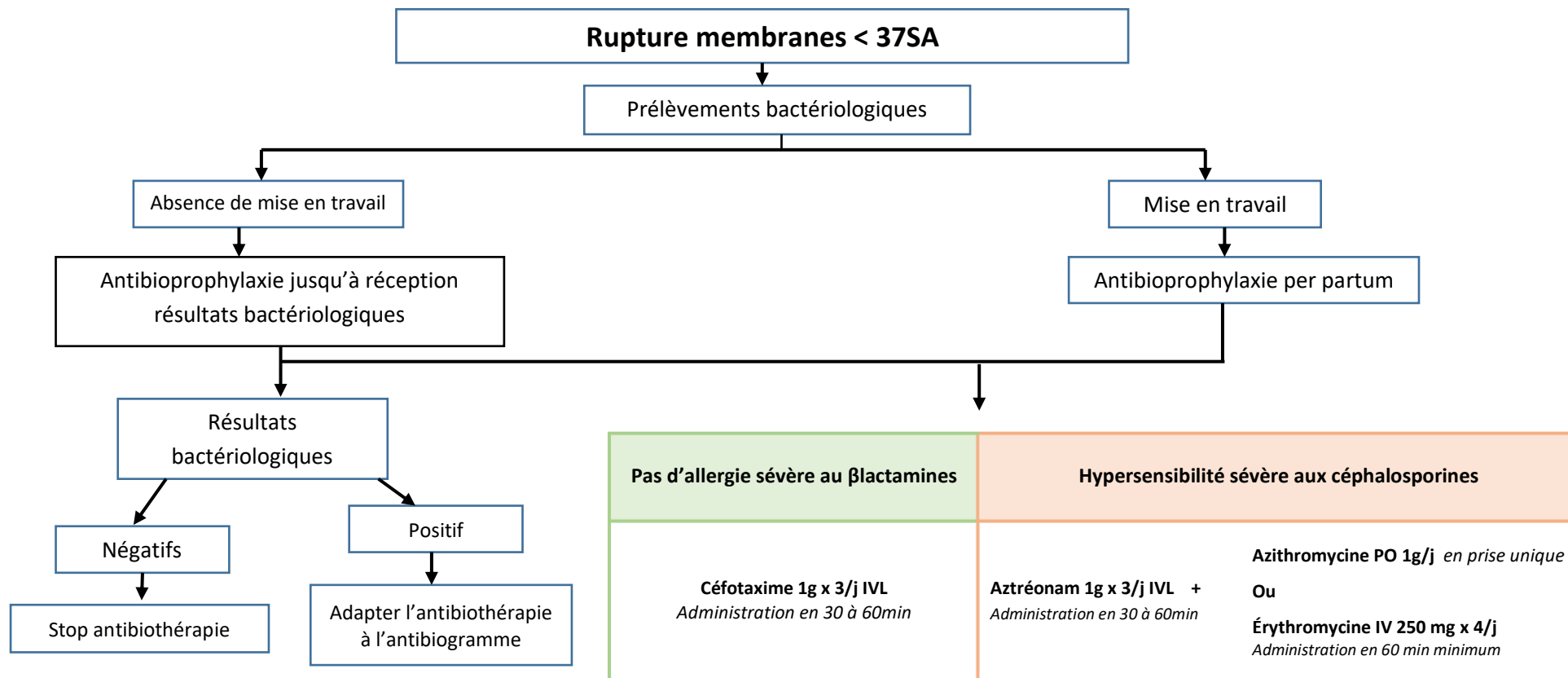
 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 13 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

c. Antibiothérapie si mise en travail avant 23 SA

En l'absence d'allergie sévère aux β lactamines	En cas d'hypersensibilité sévère β lactamines	
Céfotaxime : 1g x 3/j IVL <i>Administration en 30 à 60min</i>	Aztréonam 1g x 3/j IVL <i>Administration en 30 à 60min</i>	Azithromycine PO 1g/j <i>en prise unique</i> OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j <i>Administration en 60 min minimum</i>
<u>Nb</u> : en cas de rupture de stock d'Aztréonam : Amikacine : 15 mg/kg/j en IVL <i>en une administration par 24 h sur 30 minutes</i>		
<i>Ne pas poursuivre l'Amikacine au-delà de 48h et garder bithérapie</i>		
Attention à adapter à l'antibiogramme du germe si disponible		

d. En cas de signes d'infection intra-utérine, adaptation de l'antibiothérapie :

➡ Se référer au paragraphe A-c de la page 4 du protocole « Adaptation de l'antibiothérapie en cas de signes d'infection intra-utérine »



Si Signes d'infection intra-utérine

Céfotaxime 1g x 3/j IV + Amikacine 25 mg/kg/j (pendant 48 h maximum) en IV en une injection par 24 h sur 30 minutes

En cas d'hypersensibilité **sévère** aux B lactamines : Vancomycine 15 mg/kg (2g max) x2/j + Amikacine 25 mg/kg/24h

En cas de signe toxinique ou de choc septique réfractaire : avis médecin réanimateur et ajout **Clindamycine 900 mg x 3/j**

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 15 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

Références :

- Rupture des membranes à terme avant travail. Recommandations pour la pratique clinique du CNGOF — **Senat M-V, Schmitz T, Bouchghoul H, Diguisto C, Girault A, Paysant S, Sibiude J, Lassel L, Sentilhes.. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie.** 2020;48(1):15-18. doi:10.1016
- *Amniotic infection syndrome: nosology and reproducibility of placental reaction patterns.* **Redline RW, Faye-Petersen O, Heller D, Qureshi F, Savell V, Vogler C; Society for Pediatric Pathology, Perinatal Section, Amniotic Fluid Infection Nosology Committee.** Arch Pathol Lab Med. 2003;127(11):1290-1298.
- Evaluation and management of women and newborns with a maternal diagnosis of chorioamnionitis: summary of a workshop. Higgins RD, Saade G, Polin RA, Grobman WA, Buhimschi IA, Watterberg K, et al. [Obstet Gynecol](#) 2016;127:426–36
- Maternal deaths due to sepsis in the state of Michigan, 1999-2006. Bauer ME, Lorenz RP, Bauer ST, Rao K, Anderson FW. Obstet Gynecol 2015;126:747–52. doi: 10.1097-
- 7^{ème} rapport de l'enquête confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2016-2018
- Répertoire des antibiotiques référencés CBUPS CHU Besançon
- VIDAL hoptimal

Annexes :

Annexe 1: Schéma de synthèse du protocole

Annexe 2: Conduite à tenir devant une notion d'allergie aux bêta-lactamines (BL) et besoin d'y recourir.

Annexe 3 : Annexe 3 : Modalités de dilution et d'injection des antibiotiques IV

 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 16 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

ANNEXE 1 :

RUPTURES DES MEMBRANES < 37 SA

RUPTURES DES MEMBRANES ≥ 37 SA

DURANT L'HOSPITALISATION	<u>Cibles : E. coli > Strepto B ou agalactiae</u> <u>En l'absence d'allergie sévère aux B lactamines</u> : Céfotaxime IV 1g x 3/j <u>En cas d'hypersensibilité sévère aux B lactamines</u> : bithérapie, Aztréonam 1g 3x/jr ET Azithromycine PO 1g/j OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j (attention : à adapter à l'antibiogramme du germe si disponible) <i>Si rupture d'Aztréonam : le remplacer par de l'Amikacine IV à 15 mg/kg/24h pendant 48h maxi (garder bithérapie)</i>	- PV ou PCR SGB positive : antibiothérapie à débiter immédiatement - PV ou PCR SGB négative : antibiothérapie à débiter à H12 de la rupture
	Vaginose traitée par métronidazole (1 g/j pendant 7 j) ou Secnidazole 2 g en DU En cas de germes atypiques (résistances, <i>Strepto A ou pyogenes, Pseudomonas aeruginosa</i>, entérobactérie groupe 3 : avis Mal inf rapide et traitement hospitalier) Le traitement antibiotique est interrompu si le bilan infectieux est négatif	<u>Cibles : Strepto B ou agalactiae > E. coli</u> <u>En l'absence d'allergie aux pénicillines</u> : Amoxicilline PO 1 g x 3/j jusqu'à l'entrée en travail <u>En cas d'hypersensibilité non sévère aux B lactamines</u> : Céfazoline IV 30 mg/kg x 3/j (2g max par prise) <u>En cas d'hypersensibilité sévère aux B lactamines</u> : Azithromycine PO 1 g le premier jour puis 500mg par jour OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j (adapter à l'antibiogramme du germe si disponible)
EN COURS DE TRAVAIL	<u>En l'absence d'allergie sévère aux B lactamines</u> : Céfotaxime IV 1g x 3/j <u>En cas d'hypersensibilité sévère aux B lactamines</u> : bithérapie, Aztréonam 1g 3x/jr ET Azithromycine PO 1g OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j (attention : à adapter à l'antibiogramme du germe si disponible) <i>Si rupture d'Aztréonam : le remplacer par de l'Amikacine IV à 15 mg/kg/24h pendant 48h maxi (garder bithérapie)</i>	Si la patiente a déjà reçu ≥2g d'amoxicilline avant la mise en travail : poursuivre Amoxicilline IV 1g à H4 de la dernière prise, puis 1g/4h jusqu'à la naissance Si la patiente a reçu seulement 1g d'amoxicilline avant la mise en travail : remettre 1g à la mise en travail puis 1g/4h jusqu'à la naissance Si la patiente n'a pas eu d'antibiothérapie : mettre 2g d'emblée à la mise en travail puis 1g/4h jusqu'à la naissance <u>En cas d'hypersensibilité non sévère aux B lactamines</u> : Céfazoline IV 30 mg/kg/j x 3/j (2g max par prise) <u>En cas d'hypersensibilité sévère aux B lactamines</u> : Azithromycine PO 1 g e dose unique OU Érythromycine IV 250 mg x 4/j (adapter à l'antibiogramme du germe si disponible)

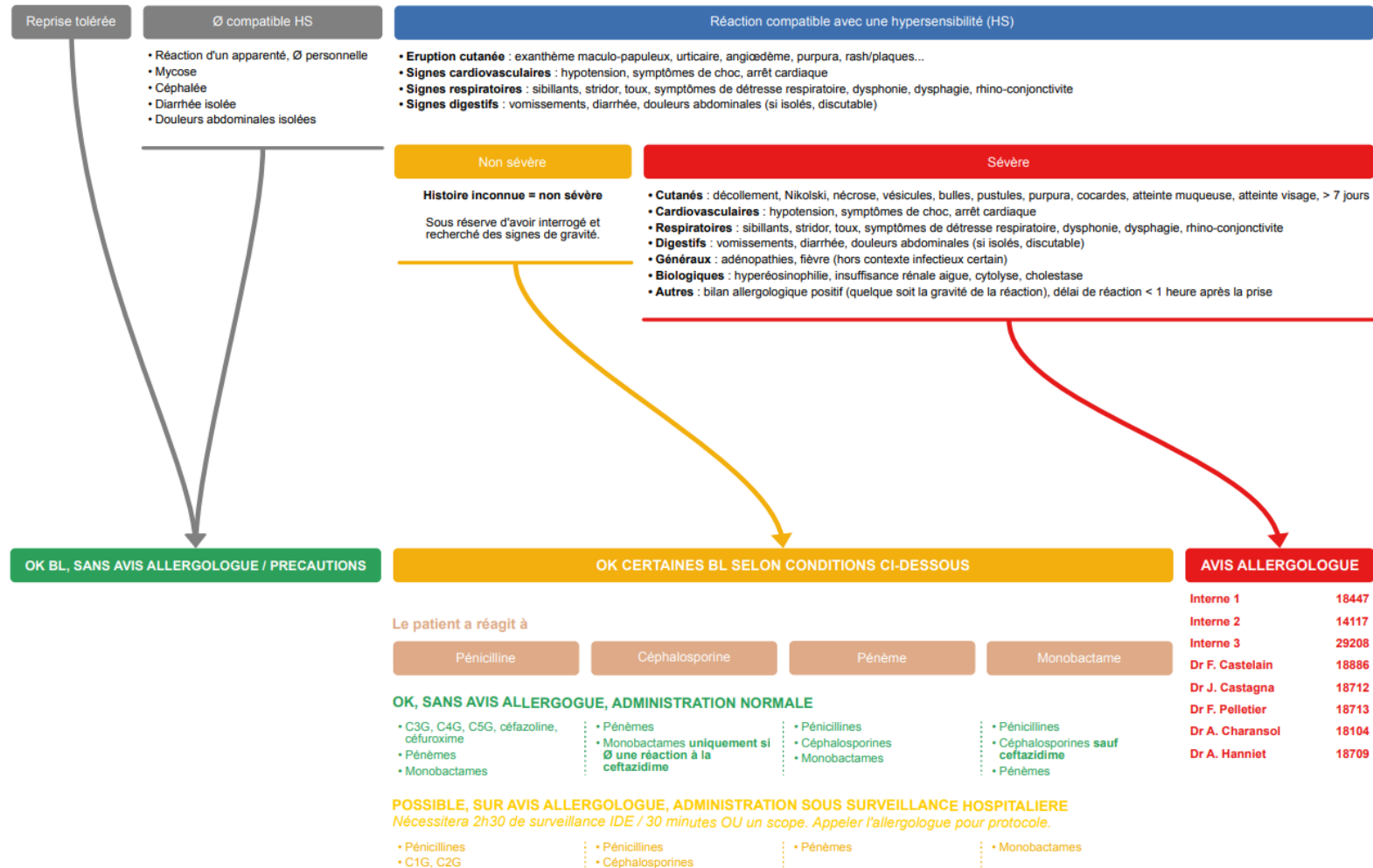
Signes d'infection intra-utérine

Céfotaxime 1g x 3/j IV + Amikacine 25 mg/kg/j (pendant 48 h maximum) en IV en une injection par 24 h sur 30 minutes
En cas d'hypersensibilité sévère aux B lactamines : Vancomycine 15 mg/kg (2g max) x2/j + Amikacine 25 mg/kg/24h

En cas de signe toxique ou de choc septique réfractaire : avis médecin réanimateur et ajout Clindamycine 900 mg x 3/j

Annexe 2

Conduite à tenir devant une notion d'allergie aux beta-lactamines (BL) et besoin d'y recourir



 POLE MERE-FEMME	PRISE EN CHARGE DES RUPTURES DES MEMBRANES AVANT TRAVAIL		CHUB_DOC_PT_0071 Version 2 Page 18 / 18
	PROTOCOLE	UNITE PMF / SALLE DE NAISSANCE	

Annexe 3 : Modalités de dilution et d'injection des antibiotiques IV

ANTIBIOTIQUE	DILUTION	VOIE D'ADMINISTRATION
AMIKACINE	50 à 100 ml dans NaCl 0,9% ou G5%	Perfusion IV (30 min)
AMOXICILLINE	50 à 100 ml de NaCl 0,9% (G5% possible mais à éviter)	Perfusion IV (30 min)
AZTREONAM	Reconstitution dans 3 ml d'eau PPI A diluer dans 50 à 100 ml de glucose 5 % ou NaCl 0,9%	Perfusion IV (30 à 60 min)
CEFAZOLINE	Soluble dans NaCl 0.9% ou G5% Max 100 mg/ml soit 1G/10mL	IVD (3 à 4 min)
CEFOTAXIME	50 ou 100 ml de NaCl 0,9% ou de G5 %	Perfusion IV (30 à 60 min)
CLINDAMYCINE	100 ml de NaCl 0,9% ou G5%	Perfusion IV (60 min)
ERYTHROMYCINE 500 mg	Reconstitution avec 10 ml d'eau PPI (20 ml pour flacon de 1 g) A diluer dans 100ml à 250ml de NaCl 0,9% ou de G5 %	Perfusion IV en 60 minutes minimum
VANCOMYCINE	Reconstitution : avec 10 ml d'eau PPI (20 ml pour flacon de 1 g) A diluer dans 100 ml à 200 ml de G5 % ou NaCl 0,9%.	Perfusion IV (60 min minimum pour 500 mg et 2h pour 1g)